



裝置心臟節律器 | 生活注意事項

心跳太慢或停頓時，節律器送出微小電流，幫心臟規律跳動

它是心臟的「備用小幫手」，只在需要時出手，不會取代心臟



掃描看電子版

為什麼需要裝節律器？



心跳太慢或會停一下

例如病竇症候群、房室傳導阻滯



改善心跳太慢造成的不舒服

頭暈、昏倒、喘、累、沒力氣

目標是預防昏倒與意外、維持安全的心跳；是否需要裝由心臟科醫師評估。

傷口這樣照顧



保持清潔乾燥

換藥與洗澡方式依醫療團隊指示



不要摳抓、不要自己塗藥

傷口癒合前不泡澡、不游泳



每天看一次傷口

注意紅、腫、熱、痛、流湯或裂開

這些要盡快聯絡醫療團隊

發燒、傷口流膿或出血不止、腫脹變大

回家後注意事項



患側手臂適度活動

別反覆高舉過肩、提重物或撞擊



隨身帶節律器識別卡

看病、看牙、做檢查前主動告知



按時回診檢查節律器

術後約 1 個月、3 個月，之後定期

可能會安排遠距監測

部分裝置能在家把資料傳回醫院

生活中的電器與環境

這些可以正常使用

手機（別放同側胸前口袋，用對側耳朵接聽）

微波爐、家電、電腦；電磁爐保持約 60 公分

機場安檢：出示識別卡，請改人工檢查

這些一定要先告知

核磁共振 MRI：多數新裝置可做，但須由團隊事前設定；電燒、電療、碎石術也一樣

避開：電焊、強力磁鐵、大型工業馬達

電池可以用多久？

電池一般可用 約 8~12 年，每次回診都會檢查電量；快沒電時會提早幾個月通知，不會突然停掉。

更換時通常只換上面的機器、導線保留，手術比第一次裝簡單。

提醒：節律器負責「不要太慢」，不能預防心肌梗塞或中風，原本的藥還是要照吃。

昏倒、胸痛、呼吸困難、持續心悸，或傷口大量出血：立即打 119

資料來源（查核至 2026-09）：

2021 ESC Guidelines on Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy（遠距監測、MRI、追蹤間隔）；

2018 ACC/AHA/HRS Bradycardia Guideline；2025 ACC/AHA/HRS Appropriate Use Criteria for ICD, CRT and Pacing。

本單張提供一般衛教，不取代個別診療；實際限制與回診安排請依您的醫療團隊指示。